

## B - ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

Οι β-αναστολείς ανέκτησαν πρωτεύοντα ρόλο στη θεραπεία της ΧΚΑ, αφού βρέθηκε ότι μειώνουν κατά 30% τη θνητότητα και κατά 25% τις εισαγωγές στο νοσοκομείο.

Έχουν ένδειξη σε όλους τους ασθενείς με ΧΚΑ σταδίου II-IV κατά NYHA, ιδιαιτέρως μετά τη φάση της αντιρρόπησης, σε συνδυασμό με α-MEA. Κύριες δράσεις τους, είναι:

1. Μείωση των όγκων της αριστεράς κοιλίας.
2. Αύξηση του κλάσματος εξώθησης και βελτίωση των δεικτών συσταλτικότητας.
3. Ελέγχουν τον μεταβολισμό των ιόντων ασβεστίου.
4. Μείωση της λειτουργικής ανεπάρκειας της καρδιάς.

Στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια έχουν δοκιμαστεί έξι (6) διαφορετικοί β-αποκλειστές. Μόνον η Καρβεδιλόλη, η Βισοπρολόλη και η Μετοπρολόλη (όλες στερούμενες ενδογενούς συμπαθομιμητικής δραστηριότητας - ISA) έχουν δείξει σημαντική ελάττωση της θνητότητας. Η Νεμπιβολόλη (εκλεκτικός β1-αποκλειστής που οδηγεί επίσης σε αύξηση της παραγωγής του NO), φαίνεται να έχει ευνοϊκό προφίλ και για αυτό χορηγείται σε ηλικιωμένους με ΧΚΑ.

| ΟΥΣΙΑ              | ΣΚΕΥΑΣΜΑ                    | Ημερήσια δόση       | t <sub>max</sub> | Χρόνος Ημιζωής |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| <b>Μετοπρολόλη</b> | <i>Lopresor</i>             | 25 mg → 200 mg      | 1,5-4 h          | 3-7 h          |
| <b>Καρβεδιλόλη</b> | <i>Dilatrend / Carvepen</i> | 6,25 mg → 25-100 mg | 4-6 h            | 6-10 h         |
| <b>Βισοπρολόλη</b> | <i>Concor / Blocatens</i>   | 2,5 mg → 10 mg      | 3-5 h            | 10-15 h        |
| <b>Νεμπιβολόλη</b> | <i>Lobivon / Bivol</i>      | 2,5 mg → 10 mg      | 1,5-3 h          | 12-24 h        |

Αρχικώς, χορηγούνται μικρές δόσεις και εφόσον γίνουν καλά ανεκτές από τον ασθενή τότε επιχειρείται αύξηση ή διπλασιασμός των δόσεων, σταδιακά, κάθε 2-4 εβδομάδες, έως την επιθυμητή ή τη μέγιστη επιτρεπτή δόση του φαρμάκου (κανόνας: “start low - go slow”).

## ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ (ΔΙΓΟΞΙΝΗ)

Οι καρδιακές γλυκοσίδες επηρεάζουν τη ροή των ιόντων Na<sup>+</sup> και Ca<sup>++</sup> στον καρδιακό μυ, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συστολή του κολλικού και κοιλιακού μυοκαρδίου.

Έχει απόλυτη ένδειξη όταν η καρδιακή ανεπάρκεια οφείλεται σε κολλική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Η δακτυλίτιδα χορηγείται μόνο σε ασθενείς σταδίου III ή IV, προκειμένου να μειώσει τον αριθμό εισαγωγών, χωρίς όμως να μειώνει τη θνητότητα.

Ενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με σοβαρή αριστερή καρδιακή δυσλειτουργία μετά την έναρξη της θεραπείας με διουρητικά και αγγειοδιασταλτικά. Η διγοξίνη, παρ’ όλα αυτά, δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με διαστολική δυσλειτουργία ή δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

Σε χορήγησή της από το στόμα, δίνονται 0,25 - 0,75 mg την ημέρα, για μια εβδομάδα (βραδύς δακτυλιδισμός) ή 0,75 - 1,5 mg σε μία και μοναδική δόση (ταχύς δακτυλιδισμός) ή ενδοφλεβίως 0,5 - 1 mg, ακολουθούμενη από χορήγηση 0,25 mg / 24ωρο, κάτω από συνεχή ΗΚΓφική παρακολούθηση (ταχύς δακτυλιδισμός). Η ενδοφλέβια χορήγηση της Διγοξίνης πρέπει να γίνεται αργά (εντός 15-30 min), για να αποφευχθεί η πρόκληση αγγειόσπασμου.

Για την αγωγή στη ΧΚΑ, το συνιστώμενο εύρος συγκέντρωσης της διγοξίνης στον ορό έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από 0,8-2,0 ng/ml σε 0,5-0,9 ng/ml. Αυτό συμβαίνει λόγω ενδείξεων καλύτερων αποτελεσμάτων σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις του φαρμάκου.

Δόση συντήρησης μπορεί να δοθεί με 0,25 - 0,5 mg την ημέρα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά στη βιοδιαθεσιμότητα μεταξύ της ενέσιμης και των από του στόματος μορφών. Σε περίπτωση αλλαγής, από την δια του στόματος σε παρεντερική χορήγηση, η δόση του φαρμάκου πρέπει να ελαττώνεται κατά 33% για την αποφυγή παρενεργειών.

Παρ’ όλα αυτά, η Διγοξίνη αποτελεί σήμερα φάρμακο 3<sup>ης</sup> επιλογής στην αντιμετώπιση της ΧΚΑ και η δόση της πρέπει να μειώνεται σε ασθενείς ηλικίας > 75 ετών ή σε αυτούς με αυξημένη κρεατινίνη ορού ή μειωμένο GFR (σε CrCl < 30 ml/min: 0,125 mg, ανά 48ωρο).

Μικρές δόσεις επιβραδύνουν την αγωγή έμμεσα (παρασυμπαθητικομιμητική ενέργεια), ενώ μεγάλες δόσεις Διγοξίνης ενεργούν με απευθείας δράση στο μυοκάρδιο.